***Para evitar la Inflamación*:**

- Mantenga su pierna elevada lo más posible durante los primeros días
- *Aplicar hielo 15min 3-4veces al día*
- Movilización activa de la cadera, rodilla, tobillo y dedos

Cuidado de la herida

- Retirar vendaje a las 24-48h
- Mantener la herida seca y cubierta
- Retirada de puntos en su ambulatorio habitual en 12-14días

***Soportar peso*:** Salvo indicación contraria, podrá soportar peso desde el primer momento. Si desea, puede utilizar muleta/bastón el primer día, después no es necesario.

FASES DE RECUPERACIÓN

FASE 1: Semana 1-2

- Rango movilidad 0-90º
- Bicicleta estática sin resistencia, sillín alto (2 veces al día 10-15 minutos)
- Mover rotula / mover tobillo / mover cadera lo máximo posible
- Contracciones cuádriceps (5segundos, 10 repeticiones, 4veces al día)
- Elevaciones pierna (200-300repeticiones)

FASE 2: semana 2-4

- Rango movilidad 0-120º
- Continuar con bicicleta-natación
- Contracción cuádriceps (5segundos, 10repeticiones, 4veces al día)
- Elevación pierna (200-300 añadir 1 Kg de peso)

Fase 3: Semana 4-6

- Rango movilidad 0-135º
- Aumentar la carga y la resistencia
- Carrera ligera (línea recta)

Fase 4: Semana 6 en adelante

- Movilidad completa
- Incrementar y maximizar la función
- Maximiza la fuerza y la resistencia
- Regresar al nivel de actividad anterior
- Regreso al nivel funcional específico del deporte

Resultado final

Usted debería poder regresar a la mayoría de sus actividades físicas después de 6 a 8 semanas, o a veces mucho antes. Las actividades de mayor impacto deben evitarse durante más tiempo.

El resultado final será determinado por el grado de daño-desgaste en su rodilla. Por ejemplo, si el cartílago articular se encuentra desgastado, entonces la recuperación completa puede que no sea posible.